

LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR: LESIONES DE LA MUÑECA Y LA MANO

E. Matilla Basoa, A.R. Trapote Cubillas, D. González-Arabio Sandoval.

La importancia de estas lesiones radica en su elevada frecuencia: las fracturas de muñeca constituyen la sexta parte de todas las fracturas atendidas en un servicio de Urgencias; y las lesiones de la mano suponen un tercio de todas las urgencias en accidentes laborales, constituyendo una de las principales fuentes de baja o incapacidad. La recuperación de estas lesiones se basa en un correcto tratamiento, y este comienza con una correcta atención en Urgencias.

FRACTURAS DE LA EXTREMIDAD DISTAL DE RADIO Y CÚBITO

Las fracturas de radio distal son aquellas cuyo trazo de fractura se localiza a menos de 3 cm de la articulación radiocarpiana. Son las fracturas más frecuentes de la muñeca. Presentan tres picos de incidencia: entre los 5 y los 14 años; en varones menores de 50 (alta energía); y en mujeres mayores de 40 años (baja energía-osteoporosis). Dependiendo del tipo de desplazamiento de los fragmentos hablaremos de:

- **Fractura de Pouteau-Colles:** La más frecuente, el 90 % de los casos. En este caso el trazo es metafisario y transversal y existe un desplazamiento en dirección dorsal y radial (dando lugar a una deformidad “en dorso de tenedor”). Esta fractura puede asociarse a avulsión de la estiloides cubital.
- **Fractura de Goyrand-Smith (o Colles invertido):** Cuando el desplazamiento se produzca hacia palmar.
- **Fractura de Hutchinson (o de Chaffeur)** Se encuentra afectada de forma aislada la estiloides radial, extendiéndose el trazo hasta la articulación radiocarpiana.
- **Fractura de Rhea-Barton:** El borde dorsal o volar de la extremidad distal del radio se desprende y desplaza acompañando al carpo y a la mano.
- **Fractura Die Punch:** Por impactación del semilunar en la superficie articular.

Las fracturas aisladas de cúbito distal son más infrecuentes.

Mecanismo lesional: caída con el brazo en extensión o traumatismo sobre la muñeca.

Exploración física: Dolor, tumefacción e impotencia funcional. Importante palpar pulso radial y comprobar la sensibilidad distal, especialmente en territorio del nervio mediano (que puede encontrarse comprometido, con mayor frecuencia en fracturas con desplazamiento palmar del fragmento).

Pruebas complementarias: Radiografía AP y Lateral, siempre dos proyecciones: AP y lateral puras, buscando líneas de fractura, desplazamientos y posibles lesiones asociadas.

Tratamiento: inmovilización mediante férula o yeso antebraquial, con o sin reducción previa (en función de la existencia de desplazamiento) o bien mediante tratamiento quirúrgico (osteosíntesis).



Radiografías AP y lateral: fractura de extremidad distal radio (Fractura de Colles)

BIBLIOGRAFÍA

- McRae, R., Esser, M.; (2010); Tratamiento práctico de Fracturas; Barcelona, España; Elsevier.
- Green, D.P. et al.; (2007); Green's Cirugía de la mano; Nueva York; Marban libros S.L.
- Vázquez Lima, M.J.; Casal Codesido, J.R.; (2012); Guía de actuación en Urgencias; España; Ofelmaga S.L.